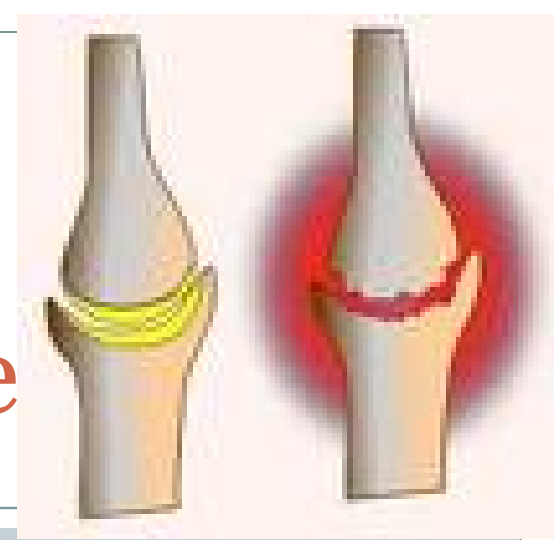




# Sémiologie rhumatologique



**PR S. BENSLEM**  
**MÉDECINE INTERNE**  
**C.H.U. IBN BADIS**



# INTRODUCTION



- La rhumatologie étudie les maladies de l'appareil locomoteur : articulations, rachis, formations juxta articulaires, os et muscles

# Anatomie



# *Les constituants de l'articulation*



- le cartilage articulaire : la seule structure fonctionnelle de l'articulation:
  - tissu très différencié, avasculaire, pauvre en cellules. il est constitué par les fibres collagènes (collagène type II), le chondrocyte et la substance fondamentale.
  - Il se compose de trois couches :
    - la couche superficielle
    - la couche moyenne la plus épaisse
    - la couche profonde calcifiée qui fait la transition avec la plaque sous chondrale



### *-La membrane synoviale*

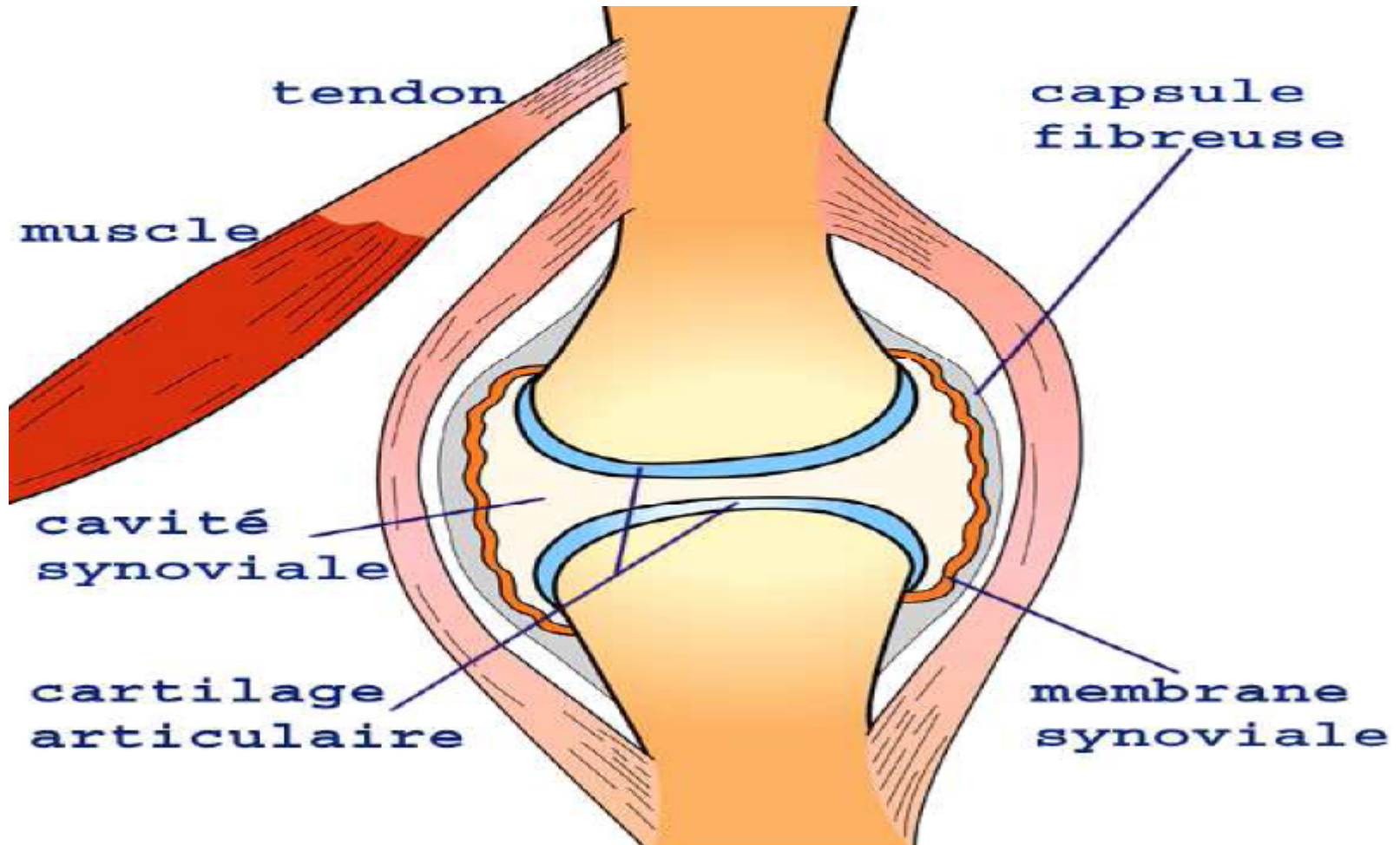
- ✓ Elle recouvre toutes les structures intra-articulaires sauf le cartilage et les ménisques
- ✓ Elle a un rôle de macrophage, capable de débarrasser la cavité articulaire des débris anormaux. Elle opère également la filtration du sérum pour constituer le liquide synovial.
- ✓ Elle sécrète des substances diverses parmi lesquelles l'acide hyaluronique, des protéoglycanes et des enzymes protéolytiques.



### *-Les bourses séreuses*

- Cavités closes qui facilitent le glissement de structures anatomique l'une sur l'autre.
- 
- ### *- Le liquide synovial*
- Présent en très faible quantité dans une articulation. Il contient environ 200 cellules mononuclées de type macrophagique par millilitre.
- 
- ### *- Les muscles, les tendons, la capsule et les ligaments*

# Rappel anatomique d'une articulation normale



# EXAMEN CLINIQUE D'UN MALADE ATTEINT D'UNE AFFECTION ARTICULAIRE



- Les maladies ostéo-articulaires mettent rarement en jeu le pronostic vital, en revanche, elles compromettent rapidement le pronostic fonctionnel et retentissent sur l'activité professionnelle, puis sur l'activité quotidienne des malades,
- **la notion de pronostic fonctionnel** doit donc occuper une place importante dans l'examen de ces patients car elle guide les indications thérapeutiques



# Interrogatoire



- La profession: en détaillant l'activité physique qu'elle nécessite;
- Les sports pratiqués;
- Les traumatismes subis;
- Les antécédents rhumatologiques et médicaux personnels et familiaux;
- Les traitements suivis et les médicaments utilisés (pathologie iatrogène, interactions médicamenteuses);
- Les antécédents digestifs personnels à type d'ulcère gastro-duodénal, car les traitements utilisés en rhumatologie comportent très souvent le risque d'accidents digestifs

# La douleur



- Le mode de début: progressif , rapide ou brutal
- le siège et les irradiations notamment pour les douleurs radiculaires
- l'intensité(difficile à faire préciser): échelle visuelle analogique(EVA), éventuellement se fonder sur la quantité d'antalgiques nécessaires pour la calmer
- Les circonstances déclenchantes
- L'horaire dans la journée: c'est un point très important car il permet d'opposer les douleurs mécaniques et inflammatoires

# La douleur



## Douleur mécanique :

maximale en fin de journée totalement calmée par le repos :  
le sujet ne souffre pas la nuit

- Elle peut apparaître le matin lorsque le sujet se lève  
s'atténuer en quelques minutes de mobilisation :  
dérouillage matinal rapide , reste sourde dans la journée



## Douleur inflammatoire :

le patient souffre la nuit , surtout au cours de la deuxième moitié

- La douleur persiste le matin au réveil avec une raideur matinale et un temps de dérouillage prolongé > à 30 mn parfois plusieurs heures.
- Elle n'est pas calmée par le repos et cède mal à la mobilisation.
- Elle ne disparaît pas totalement dans la journée.
- Rythme de la douleur: permanente ou évoluant par poussée

# La gêne fonctionnelle



- Elle est fonction de deux facteurs: la douleur et la limitation de la mobilité .
- Il importe d'apprécier la gravité de cette gêne fonctionnelle et son retentissement sur les activités professionnelles .

# EXAMEN PHYSIQUE



- Il porte sur un malade **déshabillé**.
- Dans un premier temps, il faut apprécier la stature générale du sujet , son poids, sa taille
- L'examen rhumatologique doit toujours être méthodique
- ✓ L'examen d'abord de la marche, du squelette axial, des articulations périphériques
- ✓ il doit toujours être terminé par un examen somatique complet.

# L'inspection



□ Elle apprécie:

- La coloration des téguments: normale, rosée ou franchement rouge
  - La morphologie globale de la jointure: normale, déformée par des reliefs anomaux, siège de subluxation, de luxation, trouble de l'axe du membre attitude vicieuse
- L'articulation peut être noyée dans un œdème qui fait disparaître les reliefs anatomiques.

# LA PALPATION



- Elle recherche:
  - Une modification de la chaleur locale
  - La distension de l'articulation par un épanchement intra-articulaire (hydarthrose)
  - Des points douloureux en regard des repères anatomiques
  - Préciser l'origine de la douleur: articulaire, péri articulaire ou osseuse



# la mobilisation :



- Elle doit se faire avec douceur
- Elle est réalisée en mobilisant les segments de membre l'un par rapport à l'autre , dans toutes les directions physiologiques

## On note :

- l'existence de douleurs de la mobilisation

- La limitation par la douleur ou par l'ankylose invincible

La mobilité passive ( l'examineur qui exerce le mouvement)

la mobilité active ( le malade effectue le mouvement)

la mobilité contrariée c'est-à-dire contre résistance .

# Le reste de l'examen



- L'examen local établit l'état des muscles , des artères et des veines .
- L'examen régional , concerne les articulations sus et sous jacentes, les ganglions drainant l'articulation
- L'examen des autres articulations et du rachis pour savoir si l'atteinte est mono articulaire ( une seule articulation) , oligo-articulaire (<4 articulations ) ou polyarticulaire ( $\geq 4$  articulations )



| <b>Signes radiologiques</b> | <b>Pathologie mécanique ( arthrose )</b>                                                                                                              | <b>Pathologie inflammatoire (arthrite)</b>                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>Pincement électif, asymétrique</b></p> <p><b>Ostéophytes</b></p> <p><b>Condensation sous chondrale</b></p> <p><b>Géodes sous chondrales</b></p> | <p><b>Tuméfaction des parties molles</b></p> <p><b>Déminéralisation de l'os sous chondral</b></p> <p><b>Petites géodes</b></p> <p><b>Pincement global tardivement</b></p> |

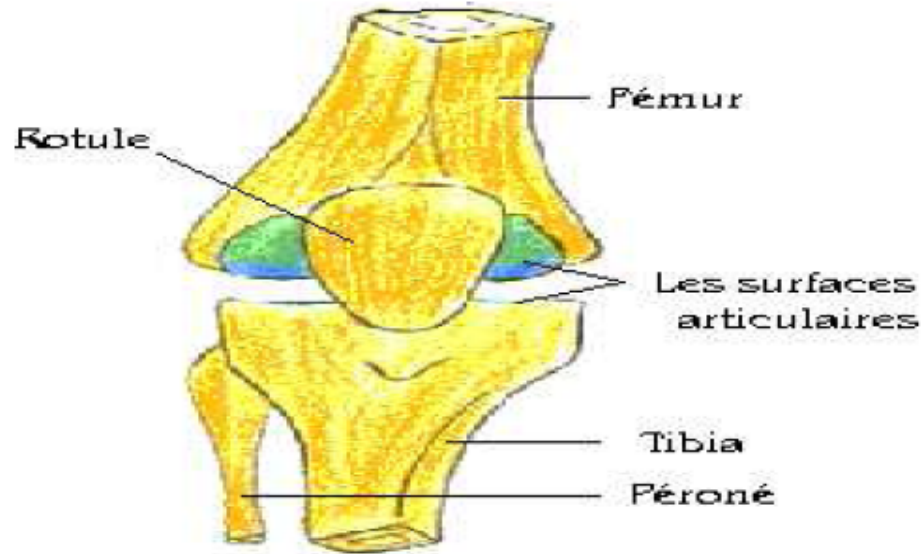


# L'articulation du genou

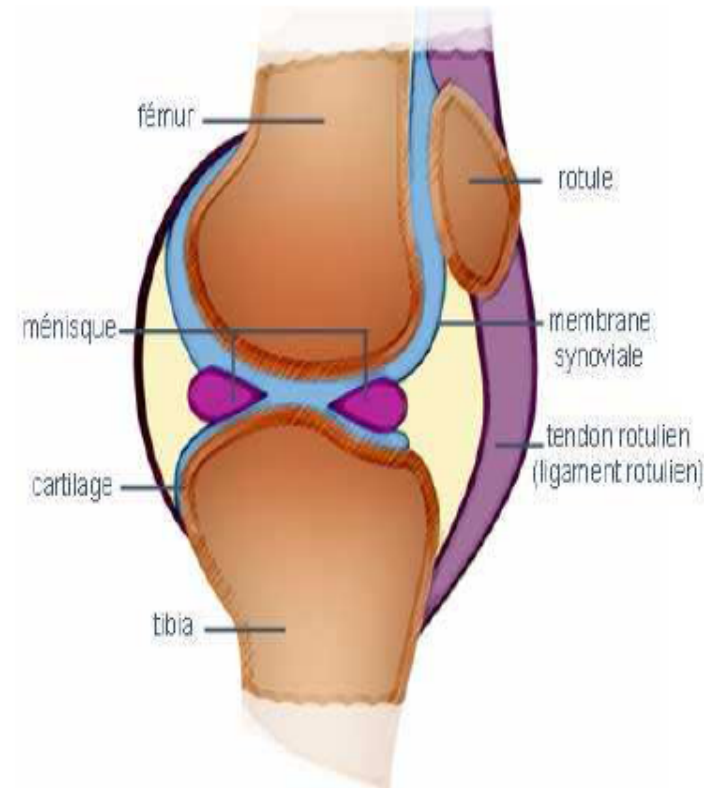
# GENOU ET PONCTION ARTICULAIRE

Le genou est une articulation superficielle et portante.

Il est constitué de deux articulations : la fémoro-tibiale et la fémoro-patellaire.



Genou de face



# A / Interrogatoire



## **Antécédents:**

- circonstances d'apparition (traumatisme....) ,
- pathologie médicale ou chirurgicale,
- prise médicamenteuse...

# A / Interrogatoire



- **Douleur:**

- caractère mécanique ou inflammatoire;
- mode d'apparition: aiguë ou chronique.
- intensité: à évaluer par L'EVA ( échelle visuelle analogique).
- siège: à faire préciser par le doigt du patient
- irradiation: rare au niveau du genou; surtout se méfier d'une douleur projetée ( cruralgie ou origine coxo-fémorale).

**D'où la règle d'examiner systématiquement la hanche devant toute douleur du genou.**

- effet d'éventuels traitement pris.



## **Blocage:**

- Vrai : ( en flexion) impossibilité d'étendre complètement le genou pendant quelques minutes (témoin d'une lésion méniscale).
- Pseudo: de durée brève  
( témoin d'une lésion cartilagineuse)

## **Dérobement:**

- genou qui lâche en particulier: en escaliers ou sur terrain accidenté.



## B / Examen d'un genou



**1)** Position debout : recherche de troubles statiques.

❖ plan frontal

*Genu varum* : genoux écartés, mesure de la distance inter condylienne interne.



➤ *Genu valgum* : genoux qui se touchent, mesure de la distance intermalléolaire interne des deux chevilles.



## Plan sagittal

- **Genu flexum :**  
impossibilité d'étendre  
complètement le genou.



- **Genu recurvatum :**  
Hyperextension du genou



## B / Examen d'un genou



### 2) Position couchée :

#### a) Inspection comparative :

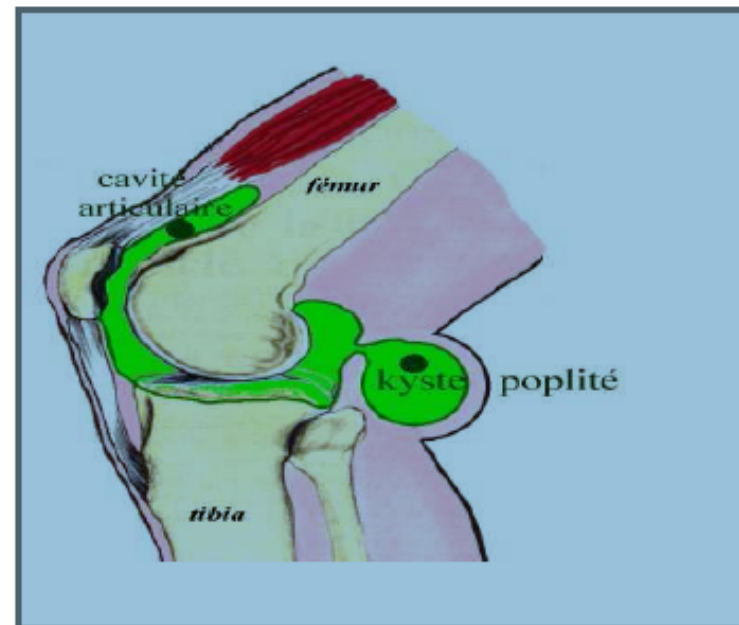
mise en évidence d'un gros genou : comblement des culs de sac quadricipitaux et disparition des méplats latéraux et sus rotuliens.

#### b) Palpation : recherche d'un épanchement intra articulaire

**a- inspection comparative :**

mise en évidence d'un gros genou : comblement des culs de sac quadricipitaux et disparition des méplats latéraux et sus rotuliens.

**b - palpation :** recherche d'un épanchement intra articulaire.



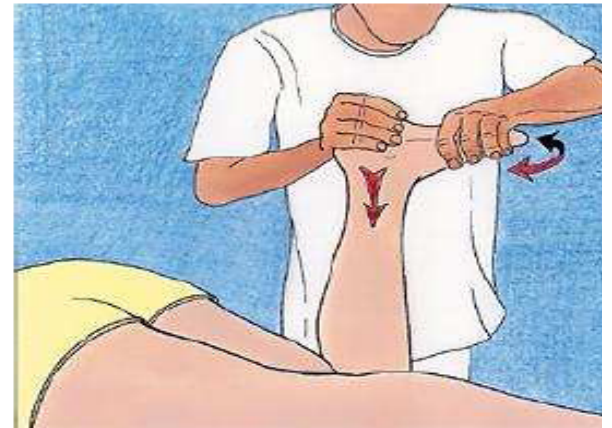
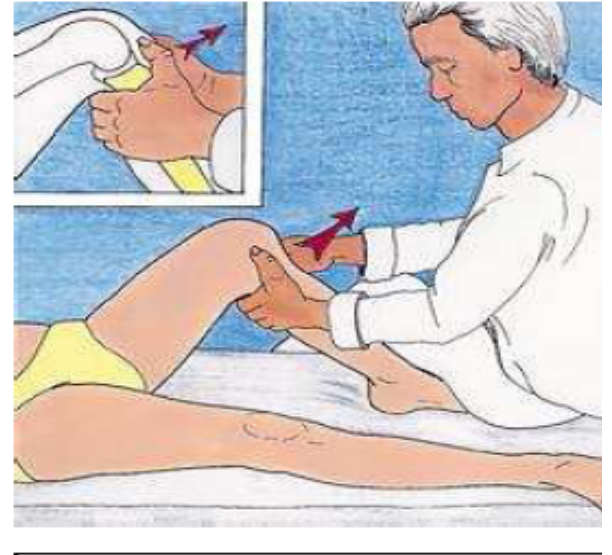
# Technique:



- Patient en décubitus dorsal, genou en extension: avec les deux mains on exerce une pression sur les culs de sac latéro- rotuliens et sous quadricipital de façon à concentrer la plus grande quantité du liquide sous la rotule; on exerce alors une pression sur la face antérieure de la rotule qui vient buter sur la trochlée créant un choc comme un glaçon dans l'eau c'est le **choc rotulien**.
- La palpation du creux poplité ( mieux en décubitus ventral genou fléchi à 90°) à la recherche d'un **Kyste poplité**

### **f- recherche de mouvements anormaux :**

- Tiroirs : antérieur et postérieur, test de Lachman ; si la manœuvre est positive elle témoigne d'une lésion du LCA ou LCP (ligament croisé antérieur ou postérieur).
- Mouvements de latéralité : interne ou externe.
- Lésions méniscales: Manœuvres méniscales (Grinding test d'Apley...)



# C / Ponction Articulaire



- Complément de l'examen clinique
- Systématique devant tout épanchement (sauf hémophilie et troubles de la coagulation).
- Nécessité des mesures d'asepsie rigoureuse: se laver les mains , matériel stérile à usage unique, badigeonnage par un produit iodé (Bétadine)....



# Liquide de ponction



## Liquide mécanique

clair, jaune citrin

Visqueux

pauvre en cellules  $< 1000 \text{ GB/mm}^3$  ( $< 50\%$  de PNN)

## Liquide inflammatoire

- Jaune foncé, trouble, parfois purulent
- Fluide.
- Riche en cellules  $> 2000 \text{ GB/mm}^3$  ( $> 50\%$  de PNN)

Le liquide hémorragique (qui ne coagule pas) doit faire l'objet d'analyse cytologique bactériologique